

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD GLOBAL (EEAG / GAF)

Eje IV: Funcionamiento Global • Escala Heteroaplicada de Funcionamiento Psicológico, Social y Ocupacional

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG; Eje V del DSM-IV-TR).
Nombre Original	Global Assessment of Functioning Scale (GAF; APA, 1987, 2000; basada en GAS de Endicott, 1976).
Autor Institucional	American Psychiatric Association (APA; Washington, DC, EE.UU.).
Adaptación Hispana	Criterios oficiales DSM-IV-TR (Masson / Editorial Médica Panamericana, España y LatAm).
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento Global. Continuo hipotético de salud mental versus gravedad patológica.
Tipo de Instrumento	Escala de juicio clínico cuantitativo graduada de 1 a 100 puntos agrupados en deciles.
Población y Rango	Niños mayores, adolescentes y adultos con cualquier cuadro psicopatológico.
Tiempo de Administración	2 a 3 minutos de juicio profesional tras la entrevista clínica diagnóstica.
Régimen de Licencia	Dominio público científico / Integrada en manuales diagnósticos internacionales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CONTINUO INTEGRAL DEL FUNCIONAMIENTO

La **EEAG (GAF)** constituyó el Eje V del sistema diagnóstico multiaxial del DSM-IV (APA, 1994, 2000), derivando de la clásica Escala de Evaluación Global (GAS; Endicott et al., 1976). Su fundamentación clínica se apoya en tres directrices operativas esenciales:

- Fusión Sintomático-Funcional:** La escala integra en un único vector cuantitativo tanto la gravedad de los síntomas psiquiátricos como el nivel de actividad relacional, laboral/académica y personal.
- Exclusión de Limitaciones Físicas y Ambientales:** La puntuación debe reflejar exclusivamente la interferencia derivada de causas psicológicas y psiquiátricas. Si un paciente no trabaja debido a paraplejía física o desempleo coyuntural, esa limitación no se computa como caída en la EEAG.
- Regla del Polo Más Severo:** Si la gravedad sintomática y el nivel funcional discrepan, **la calificación final debe situarse siempre en el nivel más deteriorado** (ej. un sujeto con empleo pero con ideación suicida grave se sitúa en el tramo de gravedad).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ESTRATOS (ESCALA 1 A 100)

Tramo EEAG	Nivel Clínico	Anclajes y Manifestaciones Descriptivas del DSM-IV-TR
91 a 100 pts	Actividad Superior	Ausencia de síntomas; funcionamiento óptimo en todas las esferas; valorado positivamente por otros.
81 a 90 pts	Síntomas Mínimos	Síntomas ausentes o mínimos (ej. ansiedad leve ante un examen); buen funcionamiento general.
71 a 80 pts	Síntomas Transitorios	Reacciones esperables ante estresores psicosociales (ej. discusión familiar); leve interferencia temporal.
61 a 70 pts	Síntomas Leves	Afecto depresivo leve o insomnio leve; alguna dificultad social o laboral pero conservando autonomía.
51 a 60 pts	Síntomas Moderados	Afecto aplanado, crisis de angustia circunstanciales; conflictos notables con compañeros o amigos.
41 a 50 pts	Síntomas Graves	Ideación suicida, rituales obsesivos severos; ausencia total de amigos, incapacidad laboral mantenida.
31 a 40 pts	Alteración Mayor	Alteración en varias áreas (trabajo, familia, juicio de realidad); delirios o depresión mayor profunda.
21 a 30 pts	Incapacidad Grave	Delirios o alucinaciones frecuentes; alteración severa de la comunicación o juicio; aislamiento total.
11 a 20 pts	Peligro Ocasional	Algún peligro de causarse daño o dañar a otros; o fallas graves en higiene personal básica.
1 a 10 pts	Peligro Persistente	Peligro persistente de lesionarse gravemente a sí mismo o a otros; o incapacidad higiénica absoluta.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Estudios multicéntricos internacionales y de habla hispana respaldan su utilidad clínica y pericial:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Confiabilidad Interjueces	CCI $r = 0.72 - 0.86$	Buena concordancia entre clínicos cuando disponen de información clínica completa.
Sensibilidad al Cambio	Tamaño efecto $d = 0.78$	Excelente para monitorizar la recuperación funcional tras el alta hospitalaria.
Validez Predictiva (Ingresos)	Odds Ratio = 4.2	Puntuaciones ≤ 40 son el predictor más potente de reingreso psiquiátrico agudo.
Validez de Criterio	$r = -0.76$ (WHODAS)	Fuerte correlación inversa con escalas de discapacidad estructuradas de la OMS.
Validez Convergente	$r = -0.71$ (CGI-S)	Alta correspondencia con la Escala de Severidad de la Impresión Clínica Global.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y ALGORITMO DE ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN

- **Paso de Selección del Decil:** El clínico revisa secuencialmente los deciles comenzando desde el estrato superior (91-100) hacia abajo, deteniéndose en el primer decil que describa la severidad de los síntomas o el nivel funcional del paciente.
- **Ajuste Fino Intradecil:** Cada decil abarca 10 puntos (ej. 41 a 50). Se sitúa la puntuación en el extremo superior del intervalo (ej. 49-50) si el sujeto está al borde del siguiente escalón; o en el extremo inferior (ej. 41-42) si los síntomas son persistentes.
- **Marco Temporal de Evaluación:** Habitualmente evalúa el momento actual o la semana previa. En peritajes forenses, puede consignarse la puntuación en el peor momento del último año para valorar incapacidad permanente.

6. PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA-ADMINISTRATIVA

Estratificación	Rango EEAG	Gravedad Funcional	Criterios Asistenciales y Jurídico-Laborales
Normofuncional	71 a 100 pts	Buena salud / Adaptativo	Autonomía social y laboral plena; remisión de sintomatología clínica.
Disfunción Leve	61 a 70 pts	Interferencia leve	Manejo ambulatorio habitual; preservación del puesto de trabajo y vínculos.
Disfunción Moderada	51 a 60 pts	Interferencia moderada	Baja laboral temporal justificada; necesidad de psicoterapia estructurada.
Incapacidad Severa	≤ 50 pts	Deterioro psiquiátrico grave	Umbral estándar de incapacidad laboral permanente y hospitalización de día.
Riesgo Vital	≤ 30 pts	Emergencia psiquiátrica	Indicación perentoria de ingreso en unidad hospitalaria de agudos.

EL UMBRAL CLÍNICO Y LEGAL DE LOS 50 PUNTOS (EEAG ≤ 50):

En psiquiatría clínica y medicina evaluadora laboral (Tribunales Médicos / INSS), una puntuación sostenida de **EEAG ≤ 50** constituye el dintel normativo de **incapacidad psiquiátrica grave**, justificando subsidios por invalidez o la necesidad de ingreso en hospitalización de día.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE TOMA DE DECISIONES ASISTENCIALES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROTOCOLO SECUENCIAL DE ASIGNACIÓN ASISTENCIAL BASADO EN LA EEAG:

- **Paso 1 (Cálculo de Línea Base):** Evaluar la EEAG en el primer contacto clínico. Si $EEAG \leq 30$, activar de inmediato el protocolo de prevención del suicidio o ingreso hospitalario involuntario/voluntario de agudos.
- **Paso 2 (Estratificación 31 a 50):** Paciente subsidiario de derivación a Hospital de Día o Centro de Salud Mental comunitario con seguimiento semanal intensivo; tramitar baja por incapacidad temporal.
- **Paso 3 (Estratificación 51 a 70):** Indicar psicoterapia ambulatoria quincenal y monitorización psicofarmacológica; evitar bajas prolongadas que cronifiquen la inactividad.
- **Paso 4 (Criterio de Alta y Rehabilitación Plena):** Puntuaciones sostenidas en $EEAG \geq 75$ durante más de 6 meses permiten programar el alta del servicio de salud mental ambulatorio con retorno a atención primaria.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: EVOLUCIÓN EN TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO SEVERO

Identificación: Varón de 28 años, bioquímico, acude a consulta acompañado por su madre con un cuadro de TOC grave de contaminación de 4 años de evolución. Dedicaba más de 7 horas diarias a lavados de manos compulsivos (con laceraciones dérmicas sangrantes) y comprobaciones reiteradas de puertas. Ha dejado de trabajar y no permite visitas en su domicilio.

Evaluación Basal EEAG:

• **Puntuación EEAG = 32 / 100 puntos (Deterioro Mayor en Múltiples Áreas;** Y-BOCS = 34/40). Incapacidad laboral absoluta, aislamiento doméstico y desnutrición por rituales de limpieza en cubiertos.

Plan Terapéutico Intensivo: Tratamiento ambulatorio intensivo coordinado: farmacoterapia con ISRS a dosis plenas potenciado con antipsicótico atípico, combinado con 20 sesiones de Exposición con Prevención de Respuesta (EPR) guiada en el domicilio y coterapia con la madre.

Seguimiento a los 6 Meses:

• **Puntuación EEAG = 68 / 100 puntos (Síntomas Leves;** Y-BOCS = 12/40). Reducción del tiempo de rituales a menos de 20 minutos diarios, curación de las lesiones cutáneas y reincorporación a un puesto de técnico de laboratorio a media jornada con adecuada relación con compañeros.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SESGO DE CONFUSIÓN SÍNTOMA-FUNCIONAMIENTO:

Un sujeto muy funcional en el trabajo que presenta celotipia paranoide severa en el hogar debe calificarse en el tramo de gravedad ($EEAG < 50$), respetando la regla del polo más severo.

SUBJETIVIDAD EN TRIBUNALES MÉDICOS:

La EEAG puede presentar variabilidad interjueces en peritajes; se recomienda apoyar siempre la calificación con escalas psicométricas estandarizadas sin- drómicas objetivas.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed., text rev.; DSM-IV-TR). APA.
2. Endicott, J., Spitzer, R. L., Fleiss, J. L., & Cohen, J. (1976). The Global Assessment Scale: A procedure for measuring overall severity of psychiatric disturbance. *Archives of General Psychiatry*, 33(6), 766-771.
3. Jones, S. H., Thornicroft, G., Coffey, M., & Dunn, G. (1995). A brief mental health outcome measure: Reliability and validity of the Global Assessment of Functioning (GAF). *British Journal of Psychiatry*, 166(5), 654-659.
4. Goldman, H. H., Skodol, A. E., & Lave, T. R. (1992). Revising axis V for DSM-IV: A review of measures of social functioning. *American Journal of Psychiatry*, 149(9), 1148-1156.